



Uraz ACJ

Staw barkowo-obojczykowy, czyli ACJ, znajduje się na górze barku. Urazy tego stawu mogą prowadzić do ograniczonego i bolesnego ruchu. Jeśli nie zostanie leczony, mogą wystąpić zmiany postawy i nieprawidłowe nawyki ruchowe, zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia problemów wtórnych.

Czego się nauczysz

Czym jest ACJ?

Urazy.

Radzenie sobie z bólem

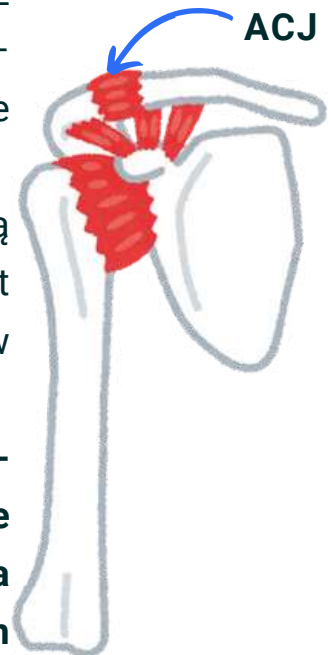
Aby poruszać się po artykule, naciśnij niebieski kwadrat

Proces rehabilitacji

staw obojczykowo - barkowy (ACJ) powstaje z dystalnego końca obojczyka i wyrostka barkowego – kostnego wyrostka znajdującego się na szczycie łopatki.

Zapewnia stabilność łopatki i umożliwia skuteczną transmisję sił między ciałem a ramieniem. ACJ jest otoczony więzadłami, które pomagają utrzymać go w odpowiedniej pozycji.

Główną przyczyną oderwania stawu barkowo-obojczykowego (ACJ) jest bezpośrednie uderzenie w boczny wyrostek barkowy podczas przywodzenia ramienia. Ten typ urazu jest powszechny w sportach kontaktowych, takich jak zapasy, hokej i rugby.



Obrażenia ACJ

Urazy ACJ często można zaobserwować u sportowców, ponieważ są one zazwyczaj związane z nagłym urazem, takim jak upadek z roweru lub niezręczny atak sportowy. Jednak każdy inny incydent z użyciem dużej siły, taki jak wypadek drogowy, może spowodować uraz ACJ.

Do pośredniego urazu więzadła krzyżowo-biodrowego może dojść na skutek upadku na wyprostowaną lub przywiedzioną rękę.

Ponieważ staw znajduje się bardzo płytko pod skórą, siniaki i obrzęk są zazwyczaj dość widoczne. Wygląd stawu może się zmienić w zależności od ciężkości urazu.

Czas, jaki zajmie Ci powrót do zdrowia, zależy w dużej mierze od ciężkości Twojego urazu i tego, jak rygorystycznie podchodzisz do swojego leczenia. Może to potrwać od 8 tygodni do 9 miesięcy i dłużej.

Przy odpowiednim leczeniu większość osób z czasem odzyskuje pełną sprawność, nie należy się jednak niepokoić, jeśli staw nadal wykazuje niewielką deformację.

Niezależnie od rodzaju aktywności, postawa ma kluczowe znaczenie.

Upewnij się, że nie garbisz się ani nie zaokrąglasz ramion. Staraj się trzymać łopatki rozluźnione do tyłu, a szyję długą, niezależnie od aktywności. Umieści to staw w optymalnej pozycji do regeneracji i zapobiegnie napinaniu się innych obszarów.



Radzenie sobie z bólem

Unieruchomienie za pomocą temblaka

Pomaga to wspomóc kontuzjowany staw i zmniejszyć obciążenie, dzięki czemu stan zapalny i ból ustępują.

Leki i inne metody leczenia

Leki takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą pomóc w zmniejszeniu bólu i ułatwieniu ruchu w pierwszych kilku dniach. Użyj termoforu na mięśnie szyi. Obszar ten często może się napinać z powodu bólu, więc użycie ciepła pomoże złagodzić to napięcie.

Noszenie temblaka i przyjmowanie leków nie jest jedynym sposobem na pozbycie się bólu. Wczesna rehabilitacja powinna koncentrować się na łagodzeniu bólu i delikatnym zakresie ruchu, aby pomóc Ci wrócić do codziennych zajęć i żyć bez bólu. Jeśli zmagasz się z silnym, uporczywym bólem, możesz być niechętny do rozpoczęcia terapii, ale wcześniej,

delikatny ruch jest kluczowy. Terapeuci powinni z Tobą pracować, aby radź sobie z bólem i stopniowo zwiększaj aktywność.

Należy unikać długotrwałego unieruchomienia, ponieważ może ono prowadzić do:

sztywność i zanik mięśni spowodowany nieużywaniem, co może potencjalnie przedłużać ból.

Ćwiczenia łopatki z zamkniętym łańcuchem ćwiczeń pomagają zwiększyć zakres ruchu i zaangażowanie mięśni, jednocześnie minimalizując obciążenie stawu barkowo-obojęczkowego, co może pomóc w zmniejszeniu bólu.

Najlepszym rozwiązaniem jest wieloaspektowe podejście do leczenia bólu, kładące nacisk na połączenie łagodzenia bólu

środki ostrożności, wczesna mobilizacja i fizjoterapia.

Unikaj wszelkich czynności, które podrażniają Twój ból w pierwszych dniach, takich jak podnoszenie ręki ponad wysokość głowy. To tylko utrudni Twoją rekonwalescencję.



Proces rehabilitacji

Rehabilitacja po urazie stawu barkowo-obończykowego koncentruje się na przywróceniu kontroli łopatki, aby umożliwić bezpieczny powrót do aktywności. Podczas gdy konkretne ramy czasowe różnią się w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta i ciężkości urazu, proces rehabilitacji można ogólnie podzielić na 4 fazy. Pamiętaj, że te fazy są kontinuum, a nie sztywnymi krokami - oznacza to, że postęp opiera się na indywidualnych objawach i celach, a nie na ścisłych ramach czasowych.

Faza 1: Łagodzenie bólu i wczesna mobilizacja

Faza ta zwykle rozpoczyna się natychmiast po urazie i obejmuje krótki okres unieruchomienia przy użyciu temblaka w celu zmniejszenia obciążenia stawu barkowo-obończykowego. Często pacjenci sami przerywają korzystanie z temblaku, gdy są w stanie samodzielnie wykonywać podstawowe czynności związane z samoobsługą.

Wczesne, delikatne ćwiczenia zwiększające zakres ruchu mogą pomóc w zmniejszeniu stanu zapalnego i bólu nawet w tej początkowej fazie.

Faza 2: Zakres ruchu i wczesne wzmacnianie

Gdy ból już na to pozwala, skupiamy się na przywróceniu zakresu ruchu bez bólu. Przed ćwiczeniami zalecamy zrobienie **terapii P-Dtr** w celu wzmocnienia osłabionych mięśni, co jest niezbędne do późniejszych ćwiczeń wzmacniających.

Faza ta rozpoczyna się od ćwiczeń zakresu ruchu ze wspomaganiami biernymi i czynnymi, kładących nacisk na rotację zewnętrzną i unoszenie ciała do przodu do poziomu barków. początkowo można unikać rotacji za plecami, przywodzenia krzyżowego i ekstremalnych pozycji uniesienia do przodu, ale **można wprowadzać stopniowo, w miarę tolerancji.**



Faza 3: Wzmocnienie i stabilność

Faza ta opiera się na poprzednich fazach i obejmuje bardziej zaawansowane ćwiczenia wzmacniające mające na celu poprawę stabilności stawu barkowo-obojczykowego. Ćwiczenia z zamkniętym łańcuchem są kontynuowane od fazy 2, z dodatkiem ćwiczeń z wykorzystaniem rurek lub linek, aby jeszcze bardziej wzmocnić mięśnie okołołopatkowe i stożek rotatorów.

Po osiągnięciu odpowiedniej siły i kontroli można rozpocząć ćwiczenia na łańcuchach kinetycznych i łańcuchach otwartych.



Faza 4: Trening ukierunkowany na konkretną dyscyplinę sportową

Ostatnia faza ma na celu przygotowanie Cię do bezpiecznego powrotu do pożądanego poziomu aktywności. Polega na wykonywaniu szeregu ćwiczeń angażujących łańcuch kinetyczny, ćwiczeń plyometrycznych i ćwiczeń wzmacniających dostosowanych do konkretnych wymagań dyscypliny sportowej danego sportowca.



Ogólnie rzecz biorąc, proces rehabilitacji powinien być dostosowany do każdego

indywidualnego pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem jego konkretnych potrzeb i celów. Komunikacja między lekarzem a fizjoterapeutą jest niezbędna, aby zapewnić skoordynowany i skuteczny plan rehabilitacji.